

## 5 - 01- Plaies de la face - Pr. Mansouri

On va assurer donc cette première série de cours de chirurgie maxillofaciale. Je crois que je vous ai eus en deuxième année pour la sémiologie maxillofaciale. Alors, cette série de cours va comporter une partie de traumatologie, donc tout ce qui est urgences et tout ce qui est fractures et plaies, et puis une partie qui va concerner la pathologie tumorale, donc les cancers de la cavité buccale que je vais faire moi-même.

Le professeur Bouilly vous fera les tumeurs bénignes de la face et les cellulites, et l'articulation temporomandibulaire qui sera assurée avec tout ce qui est salivaire, qui sera assuré par le professeur Abouchedi, et je crois que Cédazie Zekelia fera aussi une partie du programme. Alors, quelle est l'utilité de vous enseigner la chirurgie maxillofaciale ? Moi, je me demande, ça sert à quoi ? On vous emmène, on vous embête pour une spécialité qu'on n'enseignait même pas avant. Eh bien, d'abord, ceci est lié à l'importance de la face.

Vous savez très bien que quand on communique avec les gens, on communique avec le visage, avec la face. Je vois ici qu'il y a beaucoup de filles qui sont couvertes, qui couvrent la tête, donc pour des raisons de croyances, il y a des gens même qui se couvrent parce qu'ils ont un défaut à cacher, mais le visage, on le garde. Et quand on a un défaut, une dysmorphie ou un problème, ça devient problématique et le problème de la communication s'impose.

C'est un problème qu'on ne peut pas nier dans notre société, dans la société moderne. D'ailleurs, vous n'arrêtez pas de prendre vos téléphones pour vous selfier du matin à l'après-midi et essayer de montrer le mieux de ce que vous avez. Vous vous prenez de face, ce n'est pas joli, vous prenez le trois quarts, en haut, en bas, c'est ce que vous trouvez le meilleur de vous-même à offrir au grand public parce que c'est comme ça que marchent les choses aujourd'hui.

Nous n'allons pas dire là, on ne le fait pas. Nous, maintenant, c'est une monnaie courante, on offre le visage, on communique avec maintenant la photo ou bien la vidéo. Et dans cet esprit que cette discipline doit être de mise à 100 % dans les facultés de médecine, parce que nous devons soigner les faces correctement.

Une face qui a une fracture mal soignée risque non seulement d'être gênée sur le plan fonctionnel, mais d'avoir une asymétrie qui va devenir un handicap pour la personne. Une plaie qui est mal située est un handicap social, d'une part, mais aussi un handicap de travail. Vous savez très bien que les gens qui travaillent dans tout ce qui est secteur militaire, tout ce qui est secteur de la gendarmerie, de la police, de la douane ou dans certaines fonctions, ils ne peuvent pas être acceptés, leurs dossiers seront refusés lors de l'examen médical.

Parce que chez ces personnes, on fait par ailleurs un examen médical. Un policier ne doit pas comporter une cicatrice sur l'avant-bras ou sur le visage, ce n'est pas normal. C'est un homme de loi qui se présente sous le visage le plus rassurant à la communauté.

Et donc nous, nous devons absolument tout faire pour réparer correctement les traumatismes de la face, les brûlures de la face, les plaies. Autre chose, il y a une pathologie qui était souvent par en pauvre de plusieurs disciplines qui est la pathologie tumorale. Et nous sommes ici au Maroc toujours confrontés à des diagnostics dépassés exactement comme le cancer du sein, comme le cancer du colon, comme tous les types de cancers.

Quand les gens sont pauvres, ignorants et éloignés des centres de santé, ils ne vont pas consulter. Parce qu'on ne va pas dire, parce qu'il n'y a pas d'hôpital, c'est pour cela que les gens ne consultent pas. On peut avoir un hôpital, il y a un médecin qui pose le diagnostic et le réfère au spécialiste, mais si la personne est ignorante, quand elle voit l'ulcération dans la bouche, elle va passer à la médecine parallèle.

Sinon, arrêtez de faire le café, la pharmacie, la pomade, où l'ulcération va grandir et le cancer va s'étendre, jusqu'à ce que nous, il arrive à un stade T4, T2, T3. Et là, on compte sur vous, on vous enseigne ce cours, pour faire le dépistage. Là, c'est la partie tumorale.

L'articulation temporomandibulaire, donc concernant cette articulation, c'est exactement comme le genou, elle va poser les mêmes problèmes qu'un genou, qu'un coude, ou bien une épaule. Donc, elle risque d'être raide, elle risque d'être limitée. Et comme c'est une articulation qui contribue à la mastication, donc les personnes qui ne sont pas soignées correctement vont être handicapées aussi, parce qu'elles vont être privées de l'alimentation normale.

Elles vont vivre et survivre à tout ce qui est liquide, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est pour cela qu'on vous enseigne toute cette panoplie de pathologies. Donc, j'essaierai de vous faire 30 minutes vers la fin, si j'ai le temps, sur les malformations, et sur un petit peu l'approche esthétique aujourd'hui, parce qu'avant, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique de notre époque, nous, c'était quelque chose de mal vu et qui était considéré comme quelque chose de non enseignable dans les facultés de médecine.

Or, aujourd'hui, vous savez que c'est devenu quelque chose de courant et ça s'enseigne dans les facs de médecine comme discipline, comme spécialité. Nous, en fait, nous sommes les maxillots chirurgiens esthétiques de La Paz, donc l'esthétique, vous devez avoir une idée sur ce qui se passe. Nous, nous n'allons pas vous poser des questions d'examen sur l'esthétique, mais je vous ferai une conférence d'information, comme ça vous savez un petit peu ce qui se trouve sur le marché, ce qui existe.

Et quand vous êtes dans vos cabinets, quand une patiente vient vers vous, vous dire je voudrais augmenter mes seins, je voudrais rajeunir mon visage, je voudrais faire des injections, vous savez que ça existe et on vous l'enseigne dans l'amphi, comme ça vous êtes informés, parce que si vous faites la spécialité, tant mieux, mais si vous ne faites pas la spécialité, vous devez la connaître. Vous êtes au phtalmo, mais vous avez eu quand même un enseignement de gynéco-ostétrique. La chirurgie esthétique et la médecine esthétique aujourd'hui est une entité qui existe

et qui est pratiquée couramment en ville ou en universitaire ou en secteur public, donc vous devez connaître cette approche et cette médecine aussi qui existe, qui est aussi importante que le reste.

Parce que comme on vient de le dire, l'esthétique aujourd'hui, surtout dans votre génération, il est essentiel. Dans ma génération, nous étions les premiers à faire l'esthétique et c'était pratiquement un jour bas. Les gens se sont surpris, ont prié les gens pour venir augmenter leur sein ou réduire leur sein ou faire un lifting ou une rhinoplastie.

Il y a plus de 30 ans, quand j'ai commencé mon exercice, c'était comme ça, mais maintenant c'est devenu une monnaie courante et donc vous devez connaître cet exercice, vous devez être aussi informé que possible et ça doit s'enseigner dans les facs de médecine. Donc voilà un petit peu ce qui va être enseigné. Je crois que vous aurez 14 heures de cours dans le grand module complet, c'est le module OFTALMO, ORL et MAXILO, donc dans les régions avoisées.

Bien, donc est-ce que vous avez des questions à poser, vous, les cinquièmes années? Vous avez quelque chose à dire? Oui, alors. Dieu, c'est tout stylo, parce que ceux qui sont présents, bien sûr, c'est ceux qui sont toujours présents à l'enfance. Vous allez faire une sixième année ou une sixième année et une septième année? Uniquement la sixième année? Ah, vous êtes des rescapés dans ce cas, de la septième année.

Très bien. Donc vous êtes la génération qui sera exonérée d'une septième année, tant mieux. Vous êtes content? Non? Non.

Pourquoi? Parce que quoi? Pourquoi ils ne sont pas clairs? Vous croyez qu'il n'y a pas assez de temps, vous êtes en début d'année, de cinquième année, vous croyez que vous allez être perdus jusqu'à la fin de la sixième année? Non. Vous n'êtes pas encore en sixième année, vous serez inquiet si vous êtes en sixième année et qu'on ne vous offre pas un programme. C'est une bonne nouvelle pour nous.

Il y a des pays où on nous fait les études médicales qu'en quatre ans, comme au Canada. La médecine de famille et la spécialité, cinq ans ou quatre ans. Pardon? L'heure, c'est la médecine de famille qu'il y a quatre dernières années.

C'est différent, mais il y a beaucoup de pays qui ne nous font que six ans, ça fait plusieurs années. On s'est battu pour vous réduire, c'est ça. Parce qu'en fait, on ne va pas ouvrir le débat, parce que la sixième année comme elle est actuellement, c'est une sixième année qui est entre parenthèses.

Vous êtes dans les CHU, on ne sait pas quoi faire de vous. Est-ce qu'on vous considère des externes ou des internes ou des faisant fonction d'interne? Comprenez? Vos collègues internes, ils sont internes, vous avez le même âge, la même expérience, vous sortez tous de la cinquième année. Moi, je les considère comme des internes, des sixièmes années, je leur donne la garde et

tout.

Donc, c'est un statut qui, sur le plan juridique, n'a jamais été aussi valorisé que de ce qu'il est. Donc, comme si vous perdez une année. Moi, personnellement, j'ai toujours été, parce que moi, j'ai été formée à l'étranger, je suis venue assez âgée, j'ai été dans plusieurs pays, j'ai toujours été choquée par cette sixième année qui était pour moi une année creuse.

C'est une année creuse. On n'apprend pas grand-chose en sixième année, vous la perdez. Par contre, moi, je préfère l'équivalent d'une septième année en sixième année en intramuros au CHU pour, par exemple, deux mois et demi, deux mois et demi, ça fait trois, et puis le dernier dans un dispensaire, mais correctement, bien suivi, bien en adéquation, aller comme ça.

Là, on échange dans un hôpital périphérique, mais le moyen, c'est qu'il y ait une formation correcte pour vous. Et nous, on est en train de se battre pour vous assurer une sixième année à la hauteur. Ne pensez pas que les gens dorment et qu'ils ne font rien, mais ce n'est pas facile pour nous, l'institution professionnelle dans le Maroc entier, parce qu'on vient dans le programme.

Pour faire ça, ça met du temps. Bien sûr. Mais on nous charge de tout, parce qu'il y a vous, mais nous avons des redoublants qui en sont de l'ancien système qu'on doit maintenir, et que nous ne sommes pas deux, trois étudiants.

Des fois, on en a pour 300, 400 étudiants. Les retardataires de revalidation de stages, vous avez des promotions pléthoriques, où il y a des retardataires, et ça, ce n'est pas simple pour les facultés, mais c'est une bonne chose. Ne la considérez pas une mauvaise chose, c'est une bénédiction.

L'inquiétude, ne vous inquiétez pas. Les choses vont. Vous n'êtes pas en sixième année, vous êtes en début de cinquième année.

Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, les gars. Moi, je crois. Parce que si il y a des grèves, on va se manipuler.

Mais la sixième année, les réserves des doyens. On est en train de travailler la sixième année pour qu'elle soit en anticipant, ça fait longtemps. On ne va faire pas ce qui a été fait.

Quand vous serez en sixième année, vous serez bien. En plus, vous avez la chance de pouvoir soutenir votre thèse. Début cinquième année, tu soutiens à la fin de la sixième année, quel bonheur.

Huit ans. Ils font tout pour vous. Pour tout compacter à l'issue de la sixième année. Mais ceux qui veulent faire vite, c'est un système qui vous a fait gagner peut-être deux années, pas qu'une année.

C'est clair. Donc, quand vous allez arriver, les choses seront au poids. Il faut faire une bonne cinquième année.

C'est le plus important. Vous êtes en fin d'étude, c'est la dernière année, c'est la dernière phase où vous devez être très concentré sur votre programme et sur vos études. Vous finissez votre projet et vous avez la chance d'échapper une septième année.

Donc, on revient à l'appelé et sauf si quelqu'un vous pose une question, moi je suis là, je réponds, il n'y a pas de problème. Bien donc, on revient à l'appelé. L'appelé a toujours représenté une problématique pour moi en tant que praticien parce que l'appelé est très fréquente dans nos pays, très fréquente à Marrakech, il est encore plus fréquent à Marrakech parce que c'est le Maroc profond, il y a beaucoup de jeunes, il y a la toxicomanie, il y a les accidents de la voie publique, entre autres la moto, vous savez que Marrakech est une championne de moto, donc championne d'accidents.

Il y a bien sûr la jeunesse, le problème social bien sûr qui fait que l'appelé survient dans l'agression. Donc il y a l'agression. Ici une particularité de Marrakech, moi j'ai travaillé sur cette question pendant longtemps, je l'ai publiée, même on a publié une série de mille plaies et ça m'a toujours quand on reçoit chaque soir cinquante plaies au box et entre les cliniques au minimum il y a cent jeunes qui ont une plaie sur le visage et qui sont privés d'un avenir prospère quand ils vont opter pour certains métiers.

Mais il y a aussi les filles qui veulent travailler comme hôtesse d'accueil, les filles, toute profession qui expose le visage va être déjà un handicap par définition et de la communication sociale parce que la plaie engendre la cicatrice et la cicatrice est sanctionnelle. Vous comprenez ce que c'est que sanctionnelle ? C'est-à-dire qu'elle donne une mauvaise note, comme une sanction à l'être humain qui communique. Vous êtes dans une banque, au guichet, il y a une jeune personne qui porte une cicatrice sur le visage.

Dites-moi ce que vous pensez de cette personne. Nous sommes les médecins, vous êtes les élites, moi je ne parle pas du reste. Quelle est la première chose qui vous vient en tête ? Quand on est très gentil, on va dire qu'il n'y a pas de problème.

Quand vous voyez un jeune dans un guichet qui a une cicatrice, quel est le problème ? Quel est le problème qui devient pour d'autres la cicatrice ? C'est normal qu'une cicatrice soit sanctionnée. C'est normal parce que c'est une personne pour nous problématique, pour la société problématique. C'est pour cela que je vous enseigne ce cours et que c'est le premier cours que j'enseigne en cinquième année pour les étudiants.

C'est un petit cours, mais ce n'est pas un petit cours, ce n'est pas un petit chapitre chez l'être humain, c'est un grand chapitre. Quelqu'un qui porte une cicatrice, c'est quelqu'un qui porte un handicap. Et la cicatrice, elle vient de la plaie.

Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas ? Donc le plan, ça va être une introduction, classification, conduite de l'examen et conclusion. Alors, c'est quoi une plaie ? Une plaie, c'est une solution de continuité des parties mûes. Donc c'est une solution de continuité, ça veut dire, c'est ça la plaie.

Elle est fréquente chez le jeune, elle est souvent consécutive d'un traumatisme par arme blanche. La plaie, il faut qu'on fasse taire nos téléphones s'il vous plaît, le mien et le vôtre, excusez-moi. Elles sont problématiques, elles lèvent des problèmes par leur banalité, parce que nous recevons l'accidenté par exemple de la voie publique ou l'âme traumatisée par agression, vous, vous êtes aux urgences.

Par exemple, mademoiselle, vous vous appelez comment ? Ikram. Docteur Ikram est aux urgences de CHL, 6<sup>ème</sup> G, 6<sup>ème</sup> année, parce que 6<sup>ème</sup> année, vous n'allez plus être l'externe de 6<sup>ème</sup> année, vous allez être un faisant fonction. Donc, vous allez porter la blouse, vous allez assurer les urgences, vous recevez un traumatisé, soit par agression, soit par plaie.

Comment vous allez vous comporter ? Vous allez faire un examen clinique complet, vous êtes d'accord ? Qu'il soit ramené sur un chariot ou le reste, vous allez vérifier l'état neurologique, c'est ça. Ensuite, l'état hémodynamique, l'état respiratoire, je vérifie s'il bouge ses membres, s'il est bien orienté. Qu'est-ce que je vais dire ? Il n'a qu'une plaie faciale.

Il n'a qu'une plaie faciale, c'est ça que je vais dire. Je vais sortir, il n'a pas grand-chose, il a une plaie de la face. Figurez-vous, si ce jeune a une fracture des deux os de l'avant-bras, ces deux os de l'avant-bras seront peut-être opérés avec une ostéosynthèse, mais ce sera un chapitre de clôt et de fermet.

Mais une plaie, une plaie de trois centimètres sur la joue ou de quatre centimètres sur la joue, elle est problématique parce que ce jeune, l'alhamdulillah, le concours de la police, la maraudeuse. Une jeune qui fait un café ou un restaurant, la vendeuse dans un magasin, elle n'aura pas de travail. Et je dirais, j'irais même, il y a des hommes qui ne vont pas vouloir accepter une femme qui a une cicatrice sur le visage.

Il y a des filles qui mettent souvent des foulards qui cachent les cicatrices ou qui lâchent leurs cheveux parce qu'il y a des garçons qui laissent pousser la barbe pour cacher leurs cicatrices parce que c'est sanctionné. Donc banalité et avec des séquelles. Le pronostic sera amélioré par une réparation primaire adéquate.

D'ailleurs c'est pour cela que nous on fait un atelier de suture procédurale de quatre heures à la Faculté de médecine au profit des 6<sup>èmes</sup> années pour que tout médecin diplômé de cette faculté sache suturer correctement une plaie de la face. Avec une attitude stéréotypée. Ça veut dire quoi stéréotypée ? Ça veut dire je fais la même chose pour tout le monde avec les mêmes états.

Je n'oublie aucun. Plaie, lavage, parage, suture, plan par plan, antibiotiques, ordonnances, on vous le fait pendant l'atelier d'ailleurs. Donc c'est ça le seul garant d'un bon pronostic pour ces plaies.

Donc si on veut les classer, nous avons la plaie franche superficielle. Plaie franche superficielle. La plaie franche superficielle c'est une plaie qui est normalement suturable par vous.

Ça veut dire le médecin urgentiste généraliste ou même un non-spécialiste peut la suturer. Et vous avez la plaie transfixiante. Ça veut dire quoi transfixiante ? Si vous trouvez des photos, c'est une plaie qui rentre et qui pénètre l'épaisseur de la joue jusqu'à l'intérieur, ou bien qui sectionne toute la lèvre, qui sectionne tout le nez et toute l'oreille et toute la paupière.

À tous les régions, ce qui est transfixiante, ça veut dire qu'il traverse. Et vous avez la plaie avec lésion sous-jacente. C'est-à-dire petite plaie par exemple d'un centimètre, mais sous la plaie vous avez une fracture frontale, une fracture de la mandibule, une fracture du nez, et enfin nous avons la plaie avec perte de substance.

C'est une plaie où il y a un morceau qui manque. Ce qui est important pour nous, c'est pas d'apprendre ça par cœur, c'est de se demander pourquoi on les classe, parce que comme les classifications vous êtes fatigués d'apprendre les classifications classification spécialiste qui classification mais vous vous posez toujours la question classification L, M, N L, M Il ne faut pas les apprendre comme ça. Il faut se dire pourquoi on m'enseigne cette classification.

Normalement, ce sont des véritables cartes de route. Les classifications, elles servent à classer le patient et il y a une conduite à tenir conséquente. On va commencer par la dernière, on va essayer de classer ça par ordre de complexité qui va faire quoi? Est-ce qu'une plaie avec une perte de substance qui va consulter chez vous, mademoiselle, vous vous appelez comment? Docteur Morsure de chien avec perte de substance.

Voilà, c'est mon chien, il m'a mordu, j'ai une perte de substance, docteur. Je veux dire Ces plaies avec perte de substance, docteur, les règles de cette plaie. C'est pour cela que vous m'enseignes les classifications, pour que vous reteniez les conduites utiles par rapport à ces classifications.

Docteur, j'ai une morsure de chien docteur viscéraliste plasticien les urgences direct direct parce que j'ai une référence bibliographique sur alors qu'est-ce qu'il faut faire avec perte de substance les morsures on ne les suture pas mais le fait précis c'est que toutes les morsures en dehors de la face ne sont pas suturables. Laver, nettoyer, on arrivera après les conduites pratiques mais une plaie avec perte de substance, une plaie sans perte de substance par morsure si elle arrive avant la sixième heure on peut la suturer sous couverture d'antibiotiques avant la sixième heure avant la sixième heure une plaie avec perte de substance le médecin généraliste est capable sur une face de fermer une perte de substance de trois centimètres d'un de quatre. Non.

Donc c'est une plaie qui sera référée au spécialiste en tant que généraliste il faut faire quelque chose il faut laver, nettoyer, protéger mettre un pansement mais ce n'est pas parce qu'il y a la perte de substance vous allez protéger cette plaie la nettoyer s'il y a de la nécrose, s'il y a des saletés s'il y a de la boue, s'il y a un corps étranger je vais faire une anesthésie locale je vais laver, nettoyer mettre du Tulgra et protéger et envoyer au spécialiste donc cette classification c'est comme la carte de route. Plaie avec perte de substance c'est spécialiste que dois-je faire? Plaie avec lésion sous-jacente il y a un docteur docteur elle est de garde elle assure une garde dans une clinique de médecins urgentistes j'ai eu un accident de moto où l'assuré a fait un bateau il a eu il a eu une fracture de nez avec une plaie sur le nez ici ou une fracture sur la joue ici il y a une plaie de 2 cm mais docteur quand elle a examiné parce qu'on va continuer les cours de traumatologie je vous expliquerai comment faire pour détecter les fractures elle a examiné d'abord son patient correctement elle a suspecté une fracture devant la suspicion de fracture, je suture, je ne suture pas qu'est-ce que je fais? Je fais un scanner pour poser le diagnostic une fracture je vais mettre quelques points, nettoyer laver, tout comme d'habitude je nettoie parce que l'infection, je dois lutter contre l'infection, je protège et j'envoie chez le spécialiste une plaie contuse qu'est-ce que je fais? ça dépend une plaie contuse, la joue vous devez la parer correctement sinon c'est une grosse plaie contuse vous allez nettoyer, laver enlever les tissus nécrotiques et puis vous l'envoyez au spécialiste plaie transfixiante sur une paupière, je crois que ça relève du maxillot ou de l'ophtalmo et c'est une urgence donc il faut protéger l'oeil parce que même si vous ne suturez pas vous devez savoir faire un pansement et prescrire une ordonnance l'antibiotique, l'anti-inflammatoire, l'antalgique les gouttes, vous protégez le sérum anti-tétanique et vous envoyez au spécialiste plaies franches et superficielles théoriquement vous devez les suturer ou non si vous êtes diplômé de la faculté de médecine de Marrakech tous les médecins de Marrakech savent suturer les plaies avec tous les ateliers que fait l'AMIMA normalement vous devez savoir les suturer mais devant cette plaie franche superficielle je mets juste un pansement de protection je mets juste un pansement de protection j'élimine l'urgence hégitale et ce n'est que sur un patient stable et stabilisé que je vais fermer et faire la suture sur un patient stable et stabilisé ou là en bon état général je vais l'allonger je vais préparer ma table l'anesthésie, les gants, le fil tout ce qu'il faut faire une anesthésie locale, laver, nettoyer faire des sutures minutieuses anatomiques et esthétiques et je dois être capable en tant que médecin généraliste de le faire 1. Vous rendez service au patient il est de taille le service quand on suture une plaie à un enfant ou à un adulte on rend service 2. Vous vous rendez service parce que vous touchez des honoraires c'est normal la profession médicale est une profession de pratique c'est trois cents il y a bien sûr minimum hein parce que ça fait longtemps nous qu'on a des promotions qui dépassent 300 parce qu'on vous reçoit en sixième année pour les ateliers et donc je vois que les promotions sont nombreuses 300 sur ces 300 combien vont devenir professeurs ou les médecins de la santé publique et combien vont exercer dans les cabinets 60% la moitié non madame pour ne pas donner un chiffre moi je ne sais pas donner les chiffres moi je dirais 80% parmi vous vont faire de la médecine libérale dans les enfants de médecine nous on ne forme pas des médecins publics on forme des médecins privés c'est une profession libérale la médecine est une

profession d'abord d'exercice libéral quelques-uns parmi nous feront la médecine les médecins publics et des exceptions feront l'enseignement par promotion maximum c'est normal on a besoin de médecins qui rendent service et qui est disponible pour les patients disponible pour les humains et qui rendent service et le médecin c'est le cabinet médical bien sûr quand je crois beaucoup les collègues qui font l'exercice public parce qu'ils font beaucoup de sacrifices et qui décident de vivre le statut du médecin de la santé publique mais ils ne sont pas très nombreux les cabinets médicaux c'est ce qu'il y a de plus et donc vous allez suturer des plaies si vous êtes des médecins généralistes ou si vous êtes des chirurgiens bien sûr, tout chirurgie confondue gynéco, ORL, maxilof, thalmo, plastique, trauma, tout ça est-ce que c'est clair que la plaie est une urgence c'est l'urgence la plus fréquente aux urgences pour tout l'hôpital, peu importe l'hôpital dans le monde entier qu'est-ce qu'on fait avec l'urgence la série urgence qu'est-ce qu'on fait l'être humain là où il est, il est sujet à un traumatisme il glisse, il tombe il a un accident de moto, un accident de bateau il tombe d'un arbre une mère de famille dans la cuisine il y a la plaie qui est liée à la profession les plaies de la main toutes les professions manuelles exposent le risque de plaies de la main c'est normal, et donc nous en tant qu'un médecin et surtout moi j'insiste beaucoup le médecin généraliste doit maîtriser l'art de la suture parce que la personne qui suture le plus surtout dans certaines zones c'est le médecin généraliste biologique donc c'est pour cela je vous dis que ces classifications qui sont embêtantes sont des classifications qui sont utiles pour la pratique médicale et non à apprendre par ça par exemple, je peux vous mettre une photo et vous dire, classez cette photo cochez la réponse juste est-ce que c'est une plaie franche, est-ce qu'elle est transfixiante est-ce qu'elle est contus et là, parce que j'ai une autre rubrique avec des photos, je vais vous la montrer il y a aussi une autre classification quand est-ce qu'on peut parler de plaies simples et de plaies complexes, donc une plaie simple c'est une plaie sans lésion noble et sans perte de substance il y a une cellule que vous allez suturer Thomas une perte de substance et par exemple c'est pas une plaie à côté d'un globe oculaire une plaie crânio-cérébrale elle est simple vous allez pouvoir la faire une plaie complexe, elle est dite complexe quand ? elle est gradée cette complexité c'est celle qui comporte une perte de substance c'est évident quand il y a certaines étiologies comme la morsure comme les armes à feu une plaie par arme à feu il faut l'explorer par un spécialiste c'est souvent la balle elle est quelque part en profondeur qu'il faut extraire une lésion noble par exemple une plaie de 3 cm mais avec une paralysie faciale une section du nerf facial c'est une plaie qui revient au spécialiste certaines topographies et quand il y a des lésions associées vous avez une plaie et une fracture de l'os malheur une fracture mandibulaire au frontal une embarrure, bien sûr vous allez laisser le travail ou le rechercher alors la conduite de l'examen clinique alors qu'est-ce qu'on fait ? devant toute plaie et d'ailleurs devant toute urgence faciale on agit de la même manière et devant toute urgence parce que nous sommes dans la traumatologie parce que figurez-vous quand on vous enseigne le cours par exemple je viens vous enseigner la fracture supracondyenne on vous enseigne les formes cliniques bien sûr vous détestez quand vous êtes en train d'apprendre le cours vous aimez le type de description donc quand il y a les formes cliniques quel est le problème ? il faut dire la réalité quand vous apprenez le cours et que vous trouvez les formes

cliniques ça alourdit le cours je vais peut-être exagérer ce sont les formes cliniques que vous allez rencontrer dans votre pratique courante par exemple fracture des deux os de la jambe la fracture des deux os de la jambe est souvent elle rentre souvent dans une forme clinique associée à une autre lésion les formes cliniques formes étiologiques formes en fonction associées c'est ça associer il y a une plaie elle est souvent associée les traumatismes c'est des accidents de la voie publique tout en compte de l'épidémiologie de Marrakech vous savez très bien la particularité de Marrakech vous avez remarqué qu'est-ce qui est très important les accidents de la voie publique beaucoup d'accidents de la voie publique il y a beaucoup d'urgences il y a beaucoup d'urgences il y a beaucoup de polytraumatisés polytraumatisés polytraumatisés parce que malheureusement nous avons une ville qui est pourvoyeuse de traumatisés et de polytraumatisés donc il y a une plaie ça existe mais il y a les autres une plaie avec une fracture de la jambe avec un traumatisme thoracique et donc devant tout traumatisé tel qu'il soit d'abord éliminer une urgence vitale une urgence vitale une urgence vitale c'est entre autres neurologique la face elle est à côté du crâne et un patient qui chute d'une moto et qui se trouve sur la chaussée au bord d'un trottoir avant d'avoir la plaie il a percuté le trottoir et il a peut-être une fracture frontale ou temporale et il a peut-être un hématome scapulaire qui ne s'exprime pas devant vous parce qu'il vient d'arriver et qui risque de saigner dans les heures qui suivent et donc nous, devant chaque traumatisme facial c'est un traumatisme d'un crâne facial donc on élimine une urgence vitale et s'il est intégré dans le cadre d'un polytraumatisé bien sûr il faut éliminer une urgence vitale qui doit être assistée sur le plan respiratoire, hémodynamique, neurologique les lésions associées au traitement prioritaire c'est un piéton qui était en train de traverser qui a chuté et qui a eu un écrasement de membre avec une plaie faciale est-ce que je vais me mettre à suturer la plaie faciale ? Non, je vais la protéger et on va voir cet écrasement de membre le crash syndrome ce mec-là risque d'avoir un choc toxique par les toxines qui sont libérées parce que l'urgence n'est pas aller faire l'esthétique sur le visage l'urgence est vitale donc pour nous en tant que maxillo ou en tant qu'urgentistes je vais laver, nettoyer pour ne pas avoir d'infection, protéger stop, je vais aller m'acharner pour vérifier ce qui est prioritaire et une fois les premières heures je vais faire mon anesthésie locale ou s'il y a un autre acte qui se passe au bloc avec l'anesthésie dans l'anesthésie générale je vais réparer cette plaie on fait un examen général sommaire qui doit éliminer une urgence vitale une lésion associée ou bien une plaie très hémorragique qui va nécessiter une compression ou l'anémotase les urgences vitales ou prioritaires ensuite je vais passer à l'examen de la face et je dois poser cinq questions vous voulez que je vous lâche vous reposez un petit peu oui ceux qui disent oui lèvent la main et ceux qui disent non lèvent la main non, pas bon donc je vais essayer de vous lâcher d'accord non, ils sont majoritaires donc je n'ai pas vu comment c'est fait ils sont connectés un petit test pour voir un petit peu discussion qu'est-ce qu'ils ont dit non, oui c'est 50% ça non non non non tout le monde non vous voulez continuer vous voulez qu'on continue oui oui, oui, oui ils veulent continuer vous êtes une promotion brillante bon c'est un fait c'est un fait donc devant une plaie vous allez poser cinq questions quel est l'agent causal l'agent causal il y a une conduite pratique l'agent causal c'est une plaie par couteau, par arme blanche ce sont des plaies qui sont linéaires

donc on ne pose pas de problème sauf le risque d'une profondeur qui n'est pas visible au niveau de la joue un coup de couteau au niveau de la joue en plein jour c'est une plaie de deux centimètres mais je me méfie parce que le couteau peut être très profond je vérifie s'il n'y a pas de paralysies quand même donc là c'est l'agent causal si l'agent causal est une morsure je sais que le risque d'infection est très important donc il y a une conduite d'antibiotiques de lavage, de nettoyage plus que d'habitude est-ce qu'il est isolé ou associé isolé, elle est seule associée à un écrasement de membre à une fracture de la colonne à une plaie de la rate si elle est associée, je protège et je laisse les autres agir quel type de plaie est-ce qu'elle est simple elle revient de mes compétences ou elle est complexe je la laisse au spécialiste donc je protège et j'envoie chez le spécialiste ou bien je répare moi-même la topographie il y a des topographies qui sont dangereuses une plaie du globe une plaie crânio-cérébrale je vais la laisser au spécialiste les lésions sous-jacentes une plaie même si elle fait un centimètre et qu'il y a une fracture frontale ou une fracture mandibulaire par exemple ici les plaies du menton et bien je vais mettre 2-3 points sans plus et je l'envoie chez le spécialiste pour qu'il vérifie d'abord l'état de la mandibule donc ces questions, comme ce que je vous ai dit elles sont faites pour m'orienter sur ce que je dois faire comment nous avons choisi la conduite ce n'est pas grave vous pouvez réparer sans aucun problème ça veut dire quoi aucun problème? ça veut dire que l'agent causal est anodin ça veut dire qu'il est isolé, qu'il n'y a pas de lésions associées ça veut dire que c'est une plaie où il n'y a pas de contusions, pas de pertes de substances c'est une topographie qui est accessible pour vous et qu'il n'y a pas de lésions adjacentes c'est que j'ai été très prudente quand je vous ai dit que ce n'est pas grave ce n'est pas grave, que vous ayez des urgences que vous êtes résident que vous êtes externe de garde est-ce que je peux suturer cette plaie? l'externe il est... l'externe de garde c'est clair la garde de Maxilot, je ne sais pas dans quel service il est là, il attend il veut suturer une plaie et donc quand il a une plaie et quand il apprend à suturer il a envie de suturer donc tu me dis, docteur, est-ce que je peux la suturer? non, non, tu ne peux pas la suturer il faut qu'il t'explique pourquoi le jour où tu es dans ton cabinet c'est le patient qui va vous poser la question parce que l'agent causal constitue une morsure et vous ne savez pas quoi faire comprenez ce que c'est que le dégel on ne sait pas ce qu'il dit si il est associé à une fracture sous-jacente vous allez le faussement le rassurer alors qu'il y a une merde sous la plaie il y a une fracture à réparer quel type, quelle topographie s'il y a une lésion sous-jacente vous devez vous savoir répondre quand vous voyez cette plaie quand vous êtes intelligent très vite vous posez la question quand vous avez la réponse si vous savez poser la question poser la bonne question vous savez répondre parce que les étudiants en médecine ils sont très intelligents vous le savez ça pourquoi ? pourquoi vous ne le savez pas ? en apprenant les cours et en faisant les QCM vous avez perdu vos capacités d'intelligence c'est que les études médicales ce n'est pas fait pour les intelligents à la fac de médecine on ne recrute pas d'imbéciles on recrute des premiers des personnes très intelligentes qui sont premiers de leur classe de leur lycée, de leur ville, de leur région c'est une faculté d'élite donc il n'y a pas d'imbécile donc normalement vous savez poser la bonne question et vous avez les bonnes réponses l'imbécile ne saura pas faire ses études elles sont très compliquées, elles sont lourdes elles sont difficiles il faut avoir beaucoup de force pour

pouvoir gérer les patients après, pour pouvoir se comporter correctement, pour pouvoir les soigner il faut avoir une force surnaturelle pour assurer cette profession c'est une profession difficile les études, le jour où vous portez la blouse vous avez les patients devant vous vous posez l'examen chaque jour est-ce que vous savez qui va vous passer les examens ? c'est pas nous c'est quoi ? tout simplement un vieux, un âgé de 50 ans qui présente une ulcération buccale et quel diagnostic ? mais vous allez l'avoir le vieux dans votre cabinet et c'est un patient qui va venir le matin, le soir, pour finir la consultation et vous allez le voir et bien il vous pose la question il vous pose l'examen il vous passe l'examen et vous n'avez pas le polycampé vous n'avez pas appris la veille le cours parce que nous les patients nous passent l'examen chaque jour et si vous avez été élu dans les facs de médecine c'est parce que vous êtes capable de faire appel à vos connaissances et de donner la réponse à l'instant non vous êtes gynéco vous avez des indications de césarienne qui dit que l'échographie je vais l'opérer vous avez donné la réponse les indications d'une césarienne vous cliquez à la substance cérébrale et vous avez la réponse parce que vous êtes intelligent n'oubliez jamais ça nous sommes une communauté d'élites et de premiers les étudiants, les professeurs, tout le monde tous les médecins, généralistes, spécialistes nos appartements les confrères c'est ça nous sommes la confrérie nous sommes choisis les confrères est-ce que c'est clair ? je parle des médecins parce que vous pouvez avoir un enseignant, un enseignement par un fondamentaliste mais les médecins enseignants c'est comme les médecins généralistes tout le monde est docteur en médecine tout le monde est assermenté l'examen de la face donc nous avons l'interrogatoire l'agent causal, l'examen maxillofacial l'inspection et la palpation pour répondre aux questions l'examen des cavités nasales buccales orbitaires conduits pour chercher une lésion sous-jacente l'examen neurologique facial l'examen des perles crâniennes vous savez l'examen des perles crâniennes ? vous savez faire l'examen des perles crâniennes ? vous savez poser la question la bonne pour vérifier si le patient sent parce que les fractures nasofrontales peuvent être pourvoyeuses d'une anosmie le 2, c'est quoi le 2 ? c'est facile une fracture de l'orbite, une plaie de la paupière doit chercher quand même une fracture de l'orbite et une baisse de l'acuité visuelle 3, 4 et 6 c'est quoi ? le moteur comment on fait pour les examiner ? la mobilité du globe pour le 3 et le 6 et le 4 l'optosis pour le 3, le releveur et la musculature intrinsèque de l'iris c'est facile le 7 paralysie faciale la dyssymétrie faciale vous demandez au patient de lever les sourcils de sourire, de gonfler la joue très bien le 8 vous avez une autoragie une fracture de la mandibule un choc latéral dans un choc latéral on risque d'avoir l'arcadigomatique, le candy mais aussi le rocher nous sommes en traumatologie faciale le 9 c'est facile le 9 glosso le sopharyngien c'est facile c'est la déglutition le 10 le 8 il est cardio modérateur il est il est il gâte la respiration le 11 en traumatologie on ne voit pas beaucoup sauf la traumatologie de la colonne c'est l'épaule le 12 donc c'est facile l'examen des nerfs crâniens et les perles crâniennes et vous devez les apprendre le 12 c'est très facile le 7 la sensibilité le 5 et le sensoriel voilà comment on palpe les reliefs osseux donc on va aller dans les zones par choc les robots orbitaires les robots orbitaires supérieurs, inférieurs la mobilité du maxillaire la mobilité du nez la vérification des douleurs endobuccales pour vérifier le pied du malheur ou le maxillaire

et l'articulation temporomandibulaire en demandant aux patients d'ouvrir et de fermer on va les revoir après en traumatologie osseuse et puis pour la plaie très important de nous concentrer région par région la région frontale il faut chercher une plaie de la région frontale s'il y a une déformation il faut chercher une fracture et s'il y a une plaie et un traumatisme il faut chercher une hypoesthésie sus-orbitaire parce que le 5A sort ici de chaque côté vers les sourcils donc il peut y avoir une hypoesthésie la région frontale toujours quand vous avez une déformation cherchez une rhinorée parce qu'on peut avoir une fracture de la base du crâne et s'il y a une rhinorée il faut chercher une anosmie parce que les fractures médio-faciales du milieu, puisque la lame criblée elle est juste au-dessus du nez et tout traumatisme nasofrontal va être générateur d'une anosmie et donc c'est les plaies crânio-cérébrales chez l'enfant, je vais vous faire dérouler ces plaies après, une à une, et vous poser les questions la région orbitale la région orbitale ce sont des plaies souvent rétractives je m'explique quand il y a une plaie de la paupière comme la peau est très fine elle se rétracte et vous avez l'impression qu'il y a une perte de substance donc dans ce cas protégez et envoyez au spécialiste il saura faire la part entre perte de substance et plaie sans perte de substance quand la plaie intéresse la partie interne quelles sont les voies qui existent ici ce sont les voies lacrymales vous devez devant une plaie palpébrale faire un examen ophtalmologique oubliez ce qui est écrit ici et dites-moi ce que c'est que l'examen ophtalmo simplement oui très bien excellent qui dit mieux une autre chose je n'entends pas très bien le tonus intraoculaire oui bien sûr hypotonie et hypertonie pratiquement enophtalmie et exophtalmie parce que quand tu palpes en traumatologie tu as les hématomes c'est très difficile même pour un ophtalmo de faire l'examen tu touches le globe via la paupière est-ce que c'est mou ou reculé ou bien est-ce qu'il est tendu ou avancé parce que c'est tendu ou avancé c'est un hématome parce que nous ce n'est pas l'hypertension qui est le glocan si à la traumatologie c'est un hématome c'est une exophtalmie avec un hématome et l'hématome lui-même risque de comprimer le nerf optique et créer une baisse de la qualité visuelle ou bien au contraire c'est un globe qui est reculé et qui est mou qui peut être mou parce qu'il y a un éclatement du globe mais qui peut être mou parce qu'il y a des fractures autour qui ont agrandi la qualité ou l'éclabillé dans tous les cas c'est annoté sur l'examen l'enophtalmie, l'exophtalmie l'hypotonie, l'hypertonie encore et vous allez écarter si vous remarquez que la paupière tombe c'est un ptosis et puis vous allez écarter parce qu'il y a l'hématome imaginez que c'est les plaies ou le sang c'est pas l'examen normal vous allez prendre une paire de gants et écarter et vérifier l'acuité visuelle là vous mettez de la lumière avec le portable puis vous vérifiez la mobilité du globe et midriase le réflexe photomoteur c'est facile je crois que c'est pas compliqué à faire et tout médecin sait le faire est-ce que vous savez faire ça ? est-ce que c'est compliqué ? vous regardez le patient est-ce qu'il a une exophtalmie est-ce qu'il a un globe qui avance qui est gros ou bien au contraire et vous allez palper vous allez lui demander d'ouvrir les yeux si la paupière tombe vous allez dire ptosis ou peut-être phoptosis on verra peut-être l'hématome vous allez écarter et regarder est-ce qu'il voit est-ce qu'il bouge le globe est-ce que sa pupille est de bonne qualité elle ouvre et elle ferme bien sûr vous allumez la lumière et vous éteignez pour voir si l'iris la musculature de l'iris elle se contracte et elle relâche donc elle ouvre le diaphragme et elle ferme compression du nerf

optique c'est la diminution de l'acuité visuelle et le scanner et puis les fractures, la fracturologie surtout le plancher de l'orbite qui est une urgence qui se manifeste par une diplopie hémorragie sous-conjunctivale, une hénofthalmie mais on va voir ça en traumatologie aussi la région jugale très très fréquente qu'on plaie les plaies de la joue peuvent s'accompagner de deux lésions importantes le nerf facial ou le conduit de la parotide et la glande parotide rarement le nerf infrarobitaire un jeune qui se présente aux urgences avec une plaie qui s'étend de la commissure buccale jusqu'aux lobules quels sont les organes qui risquent d'être lésés c'est le nerf facial c'est le conduit parotidien ou le canal parotidien c'est bien sûr ce que vous voyez la réponse vous l'avez sur la plaque donc vous voyez comment on répare ce nerf bien sûr et le canal ça se suture sous microscope et donc vous comprenez quand vous recevez ce genre de plaie et que vous êtes très loin de Marrakech ou loin des spécialistes ou vous êtes dans une clinique et vous assurez les urgences ou vous êtes spécialiste même quelque part dans le monde et vous voyez ça vous allez laver, nettoyer, protéger et envoyer chez le spécialiste ou bien mettre un point de suture vous allez faire l'anesthésie locale, explorer nettoyer, mettre de la bétadine et fermer, protéger 2-3 points et vous envoyer au spécialiste pour faire le travail Les plaies labiomantoniennes on sait que les lèvres sont en relation avec les dents et le salvéolaire et le maxillaire et la mandibule donc elles sont en communication avec une zone sale qui est la bouche ce sont des plaies septiques bien sûr qui sont rétractiles il y a des plaies de transfiction des fois il y a une hypoesthésie labiomantonienne quand elles sont étendues vers le nerf en bas elles peuvent s'accompagner aussi de fractures la région nasale il y a souvent une fracture du nez associée et ça peut être une plaie de transfiction dans le nez il y a souvent une fracture associée donc cet examen clinique il vous permet de répondre aux 5 questions plaie simple, plaie complexe comme conclusion il permet d'éliminer une lésion sous-jacente, une urgence vitale, une urgence prioritaire ou bien éliminer une lésion sous-jacente s'il n'y en a pas je suture ma plaie donc l'examen clinique est fondamental parce qu'il permet de classer j'ai parlé de classification la plaie, d'une plaie simple suturable par vous, d'une plaie complexe il permet de dicter la conduite pratique qu'est-ce que je fais et donc vous voyez c'est clair plaie simple, que doit faire le médecin elle est réparée par un médecin urgentiste elle se fait en ambulatoire et se fait sous anesthésie locale alors qu'une plaie complexe c'est l'urgence de l'exploration elle est protégée par vous pour éviter le risque infectieux et elle doit être explorée soit la chirurgie, soit des radios etc. Le traitement se fait au milieu hospitalier elle peut être sous anesthésie locale ou anesthésie générale Quelles sont les formes cliniques, nous avons des cas particuliers, par exemple le cas du scalp pour le scalp, avant de le suturer vous devez raser les verges parce que les cheveux vont vous embêter pour fermer la plaie c'est des conseils pratiques Question, est-ce qu'on rase le sourcil ? Non on ne rase pas le sourcil parce que les poils du sourcil vont être un repère pour vous pour aligner le sourcil si vous le rasez vous n'allez plus pouvoir l'aligner ça va faire une structure discordante avec une distorsion du sourcil et une anomalie très esthétique donc on n'a pas besoin de raser le sourcil on fait l'anesthésie locale on badigeonne avec la bétadine on fait un peu d'anesthésie locale on lave très très bien et puis après on ferme et on suture et ce sont les poils qui vont dicter l'alignement et le bord supérieur et inférieur du sourcil et d'ailleurs

quand on suture le premier point il est fait sur l'alignement du sourcil en haut donc la ligne d'alignement d'ailleurs même la même chose pour les plaies du front qui sont entre la partie chevelue et la partie glabre on lave, on nettoie, on fait un petit rasage mais le premier point qu'on fait c'est la ligne capillaire la ligne des cheveux pour ne pas avoir un décalage c'est un repère on revient donc au cours pour les muqueuses donc la muqueuse buccale par exemple la muqueuse nasale, ce sont des zones septiques et donc ils vont nécessiter la mise en place d'antibiothérapie et de soins de bouche parce que si vous ne donnez pas d'antibiotiques ça s'infecte il y a une relation avec les dents en plus quand on a une plaie les gens se brossent peu leurs dents c'est pour cela dans votre ordonnance quand il s'agit d'une plaie par exemple de la lèvre qui s'ouvre en bouche ou une plaie de la muqueuse, vous allez suturer et vous allez conseiller aux patients les soins de bouche d'abord le brossage dentaire ensuite un antiseptique buccale mais vous, vous allez prescrire des antibiotiques bien sûr parce que ce sont des plaies qui sont septiques pour les lésions osseuses quand vous avez une fracture maxillaire ou mandibulaire ou bien le malheur ou la nasale protégez la plaie et faites une tomodensitométrie toujours devant tout traumatisme facial vous allez prescrire un scanner bien sûr une plaie crânio-cérébrale donc une plaie frontale avec issue de la substance cérébrale c'est une urgence neurochirurgicale vous allez protéger la plaie faire une tomodensitométrie et demander un avis de neurochirurgie avant de fermer avant de faire quoi que ce soit des immunes, figurez-vous laver, nettoyer et protéger c'est un temps que j'estime non seulement appartenant à l'infirmier mais au médecin il faut le faire bien parce que le risque infectieux est majeur donc quand on lave une plaie laver avec du sérum mettre de la bétadine ou une compresse bétadine ou vous faites un bandage ou bien du sparadrap dessus vous avez fait du bon travail ça fait partie de la conduite pratique devant une plaie les lésions nobles, bien sûr de quelle relève du spécialiste, le globe le nerf facial, le globe oculaire c'est une urgence ophtalmologique le nerf facial c'est une urgence microchirurgicale, donc ce n'est pas une urgence immédiate mais c'est une urgence différée, ça peut attendre le lendemain quand on endort le patient sous anesthésie générale et puis on prend les loupes ou le microscope et on suture le canal paratidien aussi c'est une urgence chirurgicale et les voies lacrymales toujours des plaies qui relèvent du spécialiste les dermabrasions donc quand vous recevez quelqu'un qui dit qu'il a une plaque vous connaissez ça peut passer sans aucun problème et les gens peuvent guérir tout seul c'est possible mais une dermabrasion peut comporter des incrustations du goudron le patient est cicatrisé tout seul par son propre potentiel ou disons il ne garde aucune séquelle mais ces incrustations de goudron vont devenir tatouées après vous avez du tatouage sous la peau le noir sous la peau bleu vert sous la peau les plaies avec dermabrasion peuvent comporter des pierres donc après le patient trois mois après reviendra les cas d'octobre j'ai très mal il y a quelque chose qui me pique il se dit non non vous n'avez rien c'était juste une simple dermabrasion alors que faire pour éviter tout ça devant toute dermabrasion vous allez prendre une compresse et vous mettez vous lavez bien sûr mettre de la bétadine et puis vous allez prendre soit une compresse pour frotter ou bien une brosse mais avant de faire une anesthésie locale vous pouvez faire une imbibition donc c'est une compresse imbibée de xyloadrénaline et que vous mettez un moment sur la dermabrasion vous l'enlevez vous prenez une petite brosse

ou là une compresse et vous frottez frottez et une pince et vous décrochez décapez tous les petits corps étrangers de cette dermabrasion et nous dans notre expérience les dermabrasions des fois on les laisse à l'air libre mais bien souvent on met un pansement gras on appelle le patient 3 jours, 4 jours après il n'y a rien la peau est clean il faut les suivre bien.

Nous nous sommes dans un climat où il fait très chaud chauffe nous sommes au mois de septembre et le soleil il est pauvoyeur d'hyperchromie et une dermabrasion quand elle est exposée au soleil elle risque de devenir noire c'est une inflammation la dermabrasion c'est une brûlure de premier degré donc c'est comme une brûlure de premier degré vous devez frotter, protéger et une fois cicatrisée vous prescrivez une crème cicatrisante et un écran total donc ça mérite une attention c'est pour cela que moi je vous les mets dans la rubrique de médecin spécialiste ça mérite un avis de spécialiste Le syndrome de pare-brise vous connaissez le syndrome de pare-brise c'est les visages qui sortent à travers le pare-brise pendant les accidents quand les gens ne mettent pas de ceinture de sécurité et vous imaginez les dégâts qui sont causés parce que le verre et les débris de verre deviennent des petits morceaux microscopiques et qui vont s'incruster dans les plaies et donc nous on les fait sous anesthésie générale et on peut mettre quatre heures pour réparer un pare-brise parce qu'on les cherche chaque plaie est explorée à la recherche du verre qui s'enchasse en profondeur et donc ça nécessite l'avis d'un spécialiste Les traumatismes balistiques donc pour parler du dernier traumatisme compliqué ça nécessite de la réanimation bien sûr le maintien des espaces et un bilan lésionnel c'est très compliqué et dans chaque chirurgien dans sa carrière il ne souhaite pas avoir à faire un traumatisme balistique bon les collègues militaires ils voient ça dans les guerres les médecins militaires mais nous on n'a pas ça on n'a pas encore ce phénomène comme aux Etats-Unis des tentatives de suicide on en voit de temps à autre ça existe mais c'est très rare d'ailleurs vous avez fait des gardes aux urgences je crois que vous n'avez jamais rencontré un traumatisme par armes blanches par armes à feu, non ? vous n'avez jamais vu Alhamdoulilah pour le moment on n'a pas encore on n'a pas encore la morsure qui est un QCM la morsure j'aime bien poser cette question comme QCM vous avez vu ce qui était écrit en rouge qu'est-ce que j'ai mis ? urgence infectieuse c'est une morsure humaine ou animale par chien ou par âne dans le milieu rural on a vu beaucoup de morsures par âne et nous avons eu aussi des morsures de chien des morsures humaines les morsures humaines il peut lui arracher l'oreille lui arracher la joue, lui arracher la lèvre lui arracher le nez mais l'oreille j'en ai vu des amputations d'oreilles par morsure oui oui je ne rigole pas ça existe et de toutes les façons que ça soit la bouche de l'être humain ou la gueule d'un animal d'un âne, c'est très très sale il y a des milliards et des milliards et des milliards de germes une plaie par morsure, si elle n'est pas soignée en quelques heures, elle coule du pus à 7h, à 8h vous ouvrez, vous trouvez du pus c'est impressionnant et donc c'est une urgence infectieuse avant qu'elle ne soit une urgence esthétique donc avant de parler réparation on va parler des contaminations on ne parle pas des infections je n'ai pas mis des infections j'ai mis des contaminations parce que des infections c'est facile on met de la bétadine et on rince avec du sérum il n'y a que des infections mais la décontamination c'est diluer la quantité de germes qui se trouve dans la plaie ça veut dire laver, laver, laver laver, laver, laver vous allez prendre un litre de

sérum avec de la bétadine et vous allez laver et décontaminer, laver pour pouvoir déconcentrer les germes et diluer les germes donc c'est décontaminer laver, laver, laver faites une bonne anesthésie pour que le patient ne se sente pas et bien souvent on les fait sous anesthésie générale pour pouvoir décontaminer ses plaies correctement les laver comme il se doit et puis après ce n'est qu'après une bonne décontamination qu'on va parer les tissus dans le cadre des morsures on part parce que les berges qui sont contuses elles accrochent les germes on va couper les berges et si on arrive avant la sixième heure on va fermer au niveau de la face réparer avant la sixième heure sinon on va les laisser en cicatrisation dirigée et on va faire une déclaration obligatoire bien sûr et on s'occupe du chien comme toute morsure, le reste c'est comme toute morsure est-ce que c'est clair ? donc la plaie de la face par morsure est une urgence qui est d'infection et dans l'ordonnance vous avez vu les antibiotiques, le serume anti-tétanique, le vaccin anti-tétanique en conclusion les plaies faciales représentent l'urgence faciale la plus fréquente elles sont caractérisées par une banalité apparente mais elles sont graves par les lésions associées qui les accompagnent elles sont graves parce qu'elles peuvent être très complexes et elles vont être très handicapantes parce que quelqu'un qui n'a pas brisé beaucoup de pertes de substances il change de visage vous le savez ça il ne va plus pouvoir porter le même visage c'est comme un brûlé et donc c'est une autre personne c'est très très très handicapant donc elles peuvent laisser la conduite à tenir on l'a dit stéréotyper vous avez compris maintenant ce que c'est que stéréotyper c'est un examen clinique précis qui va dégager les lésions sous-jacentes qui va dégager l'urgence vitale qui va dégager la présence d'un corps étranger une fracture une exploration soigneuse je ferai l'anesthésie locale je vérifie s'il n'y a pas un corps étranger à l'intérieur s'il n'y a pas un nerf de coupé à l'intérieur ensuite une réparation minutieuse anatomique comme il se doit je vais vous trouver des cas à projeter très vite